

URGENCIAS NASOSINUSALES

RINOSINUSITIS AGUDA FÚNGICA INVASIVA

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

INTRODUCCIÓN

Es una enfermedad grave, de curso agudo y frecuentemente mortal. Se caracteriza por una infiltración fungica progresiva de la submucosa y vasos sanguíneos de la cavidad nasal y paranasal. El cornete medio es la zona más frecuente de invasión fungica. Conocida también como **mucormicosis rinocerebral**, es una enfermedad rápidamente agresiva y fulminante.

Factores de riesgo. La enfermedad ocurre principalmente en pacientes inmunocomprometidos como:

- Diabetes mellitus mal controlados.
- Neoplasias malignas hematológicas.
- uso prolongado de glucocorticoides.
- Pacientes VIH/SIDA.
- Otros factores: insuficiencia renal o hepática, trasplante de órganos sólidos y enfermedades autoinmunes. La neutropenia severa (recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 células/mL) es un factor predisponente.

Organismos más frecuentes: Mucor o Aspergillus species. Es necesaria una alta sospecha.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico es necesario tener una alta sospecha clínica y se confirma con pruebas complementarias.

- Evaluación urgente, con enfoque en pares craneales y endoscopia nasal.
- Síntomas como epistaxis, congestión/obstrucción nasal, secreciones purulentas, cefalea, algia facial, alteraciones visuales.
- Una escara negra intranasal en el examen físico es patognomónico de Mucor invasivo. Serán necesarias las biopsias para el diagnóstico.
- Interconsulta a ORL.

Pruebas complementarias en urgencias

- Hemograma completo con recuento y fórmula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, alanina aminotransferasa (ALT o GPT), aspartato aminotransferasa (AST o GOT), LDH, amilasa, bilirrubina, PCR, procalcitonina.
- Coagulación.
- TC de senos paranasales.
- RM para valorar extensión.

TRATAMIENTO

- **Anfotericina B** en dosis de 0,25-1,0 mg/kg/día, hasta un total de 2-4 gramos en 6 a 8 semanas. Dado su toxicidad nefrotóxica, se recomienda el uso de anfotericina liposomal en dosis de 3-5 mg/kg/día en caso de constatarse una creatinemia superior a 2,5 mg/dL o ante evidencia de progresión de enfermedad con dosis máxima de terapia estándar.
- **Voriconazol: en Pseudallescheria boydii o Aspergillus:** se usan dosis superiores debido a

su mayor resistencia, conlleva un riesgo mayor de nefrotoxicidad. El tratamiento de elección es el **voriconazol**: dosis habitual en adultos es de 6 mg/kg vía endovenosa 2 veces al día durante el primer día, posteriormente 4 mg/kg 2 veces al día por 7 días, con eventual traslape a terapia oral con 200 mg 2 veces al día. Es importante considerar que este esquema es solo válido para estas excepciones, dada la baja actividad del voriconazol en la división **Zygomycota**.

- **Debridamiento quirúrgico:** es una emergencia quirúrgica. Es necesaria una resección quirúrgica completa de los tejidos.

Nota

- Es una emergencia quirúrgica. Importante sospecharla en pacientes inmunodeprimidos.

BIBLIOGRAFÍA

- Penna M, Barahona L, Ruz P, Valdés C. Rinosinusitis fúngica invasiva aguda: Actualización en pacientes adultos y pediátricos. Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Vol.79 N°3. Santiago. Set. 2019.